



治疗抑郁症的药物

作者: [William Coryell](#), MD, University of Iowa Carver College of Medicine

Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry

已审核/已修订 1月 2026

几种类型的药物可用于治疗[抑郁症](#):

- [选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 \(SSRI\)](#)
- [5-羟色胺调节剂](#)
- [5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂](#)
- [去甲肾上腺素-多巴胺再摄取抑制剂](#)
- N-甲基-D-天冬氨酸 (NMDA) 受体拮抗剂/ σ -1 受体激动剂 (一类新型药物)
- [杂环抗抑郁药](#)
- [单胺氧化酶抑制剂 \(MAOI\)](#)
- [褪黑剂类抗抑郁药 \(阿戈美拉汀\)](#)
- [精神兴奋剂](#)
- [氯胺酮和艾司氯胺酮](#)

药物的选择可能取决于患者过去对特定抗抑郁药的反应，但选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 通常是首选药物。这些抗抑郁药通常与心理治疗一起使用。

大部分抗抑郁药物需规律服用数周才可显效。为防止复发，多数抑郁患者需连续服用抗抑郁药物 6 至 12 个月。50 岁以上的患者须连续服用长达 2 年。

不同类型的抗抑郁药具有不同的副作用。有时候，当一种药物无法缓解抑郁时，可选用另外一种（类别）或多种联合使用。

抗抑郁药与自杀风险

开始服用抗抑郁药后发生[自杀](#)的风险是一个潜在的问题。开始使用抗抑郁药或剂量增加后的短时间内，少数人确实会变得越来越躁动、抑郁和焦虑。尤其是在一些儿童和青年患者中，如果上述现象没有被及时发现和纠正则会导致自杀倾向增加。这一发现首先见于 SSRI 报告，但是这种风险可能在各类抗抑郁药物之间没有差异。如果开始服用抗抑郁药物或剂量增加后（或不不论出于任何原因）症状加重，应通知患者的医生。由于自杀念头也是抑郁症的一个症状，医生可能难以确定抗抑郁药在自杀想法和行为中起到的作用。有些研究对这一关联有疑问。

一般来说，未经治疗的抑郁症导致的自杀风险被认为高于开始使用抗抑郁药物后出现的任何暂时性风险。因此，不应因此而停止药物治疗；相反，使用抗抑郁药物的患者在开始用药后的几周内应接受密切监测。

抗抑郁药物类别

选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)

SSRI 包括西酞普兰、艾司西酞普兰、氟西汀、氟伏沙明、帕罗西汀、舍曲林和维拉唑酮，是目前最常用的抗抑郁药物。SSRI 不仅对抑郁症有效，对抑郁症经常伴发的其他精神疾病也有效。

虽然 SSRI 可能引起恶心、腹泻、震颤、体重减轻和头痛等副反应，但这些不良反应通常症状轻微或随着继续用药可减轻甚至消失。相对于 三环类抗抑郁药，SSRI 诱发的副反应更易被多数患者耐受。SSRI 导致心脏副作用的风险小于杂环类抗抑郁药。

一些人，尤其是儿童和青少年，在开始 SSRI 或增加剂量后第一周可能会增加自杀倾向。(更多信息请参阅[抗抑郁药物和自杀风险](#)。)

失眠是 SSRI 的常见不良作用，医生可通过减少剂量、在早晨给予剂量或在睡前添加低剂量的其他药物（曲唑酮）或其他镇静性抗抑郁药物来治疗。

此外，长期使用 SSRI 可能会产生其他副作用，最常见的是体重增加和性功能障碍。某些 SSRI（如氟西汀）可导致食欲不振。在开始使用 SSRI 后的最初几周内，患者可能会在白天感到昏昏欲睡，但这种影响是暂时的。

某些 SSRI，包括氟西汀、帕罗西汀和氟伏沙明，会使其他药物的活性增强。患者应与医生一起仔细审查完整的药物清单。如果突然停用 SSRI，则可引起停药综合征，常出现眩晕、焦虑、易激惹、疲劳、恶心、寒战和肌肉酸痛症状。

如果患者怀孕，如果仍然需要 SSRI，医生会与其讨论使用 SSRI 的风险和益处。然而，帕罗西汀不应使用，因为它可能导致心脏缺陷。

5-羟色胺调节剂、5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂和 去甲肾上腺素-多巴胺再摄取抑制剂

以下几类抗抑郁药与 SSRI 一样有效且安全，副作用也相似，但安非他酮和米氮平似乎不会引起性功能障碍：

- 5-羟色胺调节剂（如米氮平和曲唑酮）
- 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂（如文拉法辛和度洛西汀）
- 去甲肾上腺素-多巴胺再摄取抑制剂（安非他酮）

与 SSRI 类似，这些药物在首次使用时可能会暂时增加自杀风险，突然停用 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂可能会导致焦虑、易怒、恶心和流感样症状。

其他副作用因药物而异（参见表[用于治疗抑郁症的药物](#)）。

N-甲基 D-天冬氨酸 (NMDA) 受体拮抗剂/σ-1 受体激动剂

安非他酮/右美沙芬联合制剂自成一类，其抗抑郁作用是通过不同的作用机制实现的。

杂环类（包括三环类）抗抑郁药

杂环类抗抑郁药曾经是治疗抑郁最主要的药物，但由于其副作用较其他抗抑郁药严重，目前已很少使用。它常常导致困倦和体重增加。也可导致心率加快和站立时血压下降（称作直立性低血压）。其他的副反应，称为抗胆碱能作用，包括视物模糊、口干、意识模糊、便秘和排尿困难。抗胆碱能作用在老年人中经常更为严重。

与 SSRI 类药物相同，突然停用杂环类抗抑郁剂会诱导停药综合征。

单胺氧化酶抑制剂(MAOI)

单胺氧化酶抑制剂 (MAOI) 非常有效但很少作为首选药物，它主要用于其他抗抑郁药无效时。服用 MAOI 的患者必须遵循严格的饮食限制并采取特殊的预防措施，以避免血压突然急剧升高并出现重度搏动性头痛，这种严重的反应称作高血压危象。高血压危象可导致卒中。预防措施包括

- 避免吃含有酪胺的食物或饮料，包括散装的啤酒、红酒（含雪利酒）、烈酒、煮烂的食物、意大利咸味肠、陈乳酪、蚕豆、扁豆、酵母的提取物（酵母调味品）、无花果罐头、葡萄干、酸奶、奶酪、酸奶油、腌鲱鱼、鱼子酱、肝脏、肉馅和酱油
- 不服用含伪麻黄碱的药物，如很多非处方咳嗽药和感冒药
- 避免服用美沙芬（止咳药）、利血平（降压药）或哌替啶（镇痛药）
- 如果出现严重的搏动性头痛应立即服用拮抗剂并尽快到最近的医疗机构就诊

服用 MAOI 的患者还应避免服用其他类型的抗抑郁药，包括杂环类抗抑郁药、SSRI、安非他酮、5-羟色胺调节剂以及 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂。MAOI 与其他抗抑郁药物联用可引起危及生命的高热、肌溶解、肾衰竭和癫痫发作。这些副作用被称作抗精神病药物恶性综合征，可以致命。

与 SSRI 一样，突然停用 MAOI 可能会导致令人不快的症状。

表格		
用于治疗抑郁症的药物		
药物	一些副作用	注释
选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)		
Citalopram	性功能障碍（主要导致性高潮延迟，在某些人中也可导致性欲减退和勃起障碍）、恶心、腹泻、头痛、体重减轻（短期使用）、体重增加（长期使用）、停药综合征*、健忘、情感迟钝和容易瘀伤	SSRI 是最常用的一类抗抑郁药物。它们对广泛性焦虑障碍、强迫症、惊恐发作、恐惧症、创伤后应激障碍、经前紧张综合征以及贪食症也有效。
依他普仑		
氟西汀		
氟伏沙明		
帕罗西汀		
舍曲林		与其他抗抑郁药相比，该药过量使用引起的不良反应较

药物	一些副作用	注释
维拉佐酮		
5-羟色胺调节剂（5-HT ₂ 阻滞剂）		
米尔塔扎平	睡眠增加和体重增加	米氮平不会引起恶心或性功能障碍。
曲唑酮	长时间困倦、疼痛性的阴茎持久勃起（ 阴茎持续勃起症 ）以及站立时血压过度下降	曲唑酮最常在睡前服用，以治疗抑郁合并 失眠 的患者。
5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂		
去甲文拉法辛		
度洛西汀		
左旋米那普仑	恶心、口干、停药综合征*，过量使用可导致血压升高	小剂量服用和缓慢加量可以避免或减少药物副反应。
米那普仑		
文拉法辛		
沃替西汀		
去甲肾上腺素-多巴胺再摄取抑制剂		
安非他酮	头痛、激越、停药综合征*，少数患者出现高血压，极少数出现癫痫发作	苯丙胺对伴有 注意力缺陷/多动症 或 可卡因使用障碍 和试图 戒烟 的抑郁患者有效。安非他酮不导致性功能障碍。
N-甲基 D-天冬氨酸 (NMDA) 受体拮抗剂/σ-1 受体激动剂		
安非他酮/右美沙芬	常见副作用包括头晕、头痛、腹泻、嗜睡、口干、性功能障碍、出汗过多 严重副作用包括癫痫发作、躁狂、 急性闭角型青光眼 、血压升高和 5-羟色胺综合征	—
杂环类（包括三环类）抗抑郁药		
阿米替林	困倦、体重增加、心率加快、站立时血压下降（ 直立性低血压 ）、口干、意识模糊、视物模糊、便秘、排尿	这些药物通常不适用于老年人，因为它们在老年人中的副作用更显著。
Amoxapine		
氯米帕明		

药物	一些副作用	注释
地昔帕明 多塞平 丙咪嗪 马普替林 去甲替林 普鲁替林 Trimipramine	困难、性高潮延迟，以及停药综合征* 氯丙咪嗪和马普替林还可引起癫痫发作	药物过量可引起严重的、威胁生命的毒性作用。
单胺氧化酶抑制剂(MAOI)		
异卡波肼 Phenelzine 司来吉兰 反苯环丙胺	失眠、恶心、体重增加、性功能障碍（性欲减退、性高潮延迟和勃起障碍）、麻刺感、头晕、血压下降（尤其是站立时）和停药综合征*	服用这类药物的患者必须严格遵循饮食限制并避免使用某些药物，以免导致血压突然急剧升高并伴重度搏动性头痛（高血压危象）。 司来吉兰也有贴剂形式。丙炔苯丙胺常可用作辅助药物，从而可使患者避免饮食限制，但大剂量服用时则无此作用。
精神兴奋剂		
右旋安非他命 哌甲酯	神经过敏、震颤、失眠、口干	这些药物通常与抗抑郁药联合使用。作为抗抑郁药单独使用时无效。
褪黑素抗抑郁药		
阿戈美拉汀	头痛，恶心和腹泻	阿戈美拉汀的副作用比多数抗抑郁药少。它不会导致白天困倦，失眠，体重增加或性功能障碍。 阿戈美拉汀可能会导致肝酶水平升高。应在治疗开始前和治疗后定期测量肝酶水平。

药物	一些副作用	注释
		阿戈美拉汀尚未在美国上市。
氯胺酮和艾司氯胺酮		
氯胺酮	恶心、头晕、头痛、血压升高、心率加快、焦虑、脱离感、上瘾	氯胺酮是一种麻醉药。 氯胺酮（使用剂量低于麻醉剂量）与口服抗抑郁药联合用于治疗难治性抑郁症。 氯胺酮可以静脉、口服或鼻喷雾剂给药。 氯胺酮有时会被滥用。
艾司氯胺酮	恶心、头晕、头痛、脱离感	艾司氯胺酮可与其他口服抗抑郁药合用治疗难治性抑郁。 艾司氯胺酮可用作鼻喷雾剂
* 停药综合征是指突然停药后出现头晕、焦虑、易怒、疲劳、恶心、寒战和肌肉酸痛等症状。		

褪黑素抗抑郁药

阿戈美拉汀（美国未上市）是一种褪黑素受体抗抑郁药，可刺激褪黑素受体，用于治疗重度抑郁发作。它与其他抗抑郁药一样有效，并且具有以下几个优点：

- 它的副作用比多数抗抑郁药少。
- 它不会引起白天嗜睡、失眠、性功能障碍或体重增加。
- 它不会引起戒断症状。

阿戈美拉汀可能引起头痛、恶心和腹泻。它也可能增加肝酶水平，因此医生在治疗开始前和之后每 6 周测量一次这些水平。肝脏疾病患者不应服用阿达美拉汀。

氯胺酮和艾司氯胺酮

如果其他抗抑郁药治疗无效（这种情况称为“难治性抑郁症”），则使用氯胺酮和艾司氯胺酮作为药物治疗某些抑郁症患者。

氯胺酮也可以由医生作为麻醉剂给药。除了医疗用途外，有时也被**药物滥用**。

氯胺酮和艾司氯胺酮影响的脑机制似乎在抑郁症中发挥作用。当按照适当的精神保健专业人员的建议使用时，这些药物可以迅速改善抑郁症状。维持成功的治疗效果通常需要每周数次或较低频率地重复给药。

作为抑郁症的治疗，可静脉给予氯胺酮。

艾司氯胺酮鼻喷雾剂。